
20190624 의학과2 호흡기학

1. 폐포 손상이 발생하여 급성호흡곤란증후군(ARDS)이 발생한 성인에서 일반적으로 손상 받은 alveolar type 1 세포를 대신하기 위해서, alveolar type 2 세포가 type 1 세포로 바뀌는 통상적인 시간은(ARDS가 발생한 날을 기준으로)
 - 1) Day 1
 - 2) Day 2-6
 - 3) Day 7-21
 - 4) Day 22-42
 - 5) Day 43-60

20190624 의학과2 호흡기학

2. ARDS 환자의 경우 dependent portion의 atelectasis와 alveolar edema가 non-dependent portion보다 심하다. 이러한 병태생리를 해결하기 위한 치료 법은?

1) **Prone ventilation**

- 2) Nitric oxide inhalation
- 3) Neuromuscular blocker
- 4) Low tidal volume ventilation
- 5) Extracorporeal membrane oxygenation

20190624 의학과2 호흡기학

3. 다음 중 심박출량 감소를 시사하는 임상적 소견은?

- 1) 맥박수 증가
- 2) 호흡수 증가
- 3) 따뜻한 사지말단
- 4) 말초 산소포화도 감소

5) 모세혈관 재충혈의 지연

20190624 의학과2 호흡기학

4. 다음 중에서 섬망의 원인으로 볼 수 있는 것은?

1) 변비

2) 수혈

3) 진정제

4) 항전간제

5) 위장관 출혈

20190624 의학과2 호흡기학

5. 앉아있을 때보다 누워있을 때 vital capacity가 증가하는 상황은?

- 1) Normal person
- 2) Duchenne muscular dystrophy
- 3) advance amyotrophy lateral sclerosis
- 4) C4 motor complete spinal cord injury

5) C7 motor complete spinal cord injury

20190624 의학과2 호흡기학

6. diaphragm 의 근력을 가장 잘 반영하는 검사는?

1) maximal inspiratory pressure

2) maximal expiratory pressure

3) forced vital capacity

4) total lung capacity

5) peak cough flow

20190624 의학과2 호흡기학

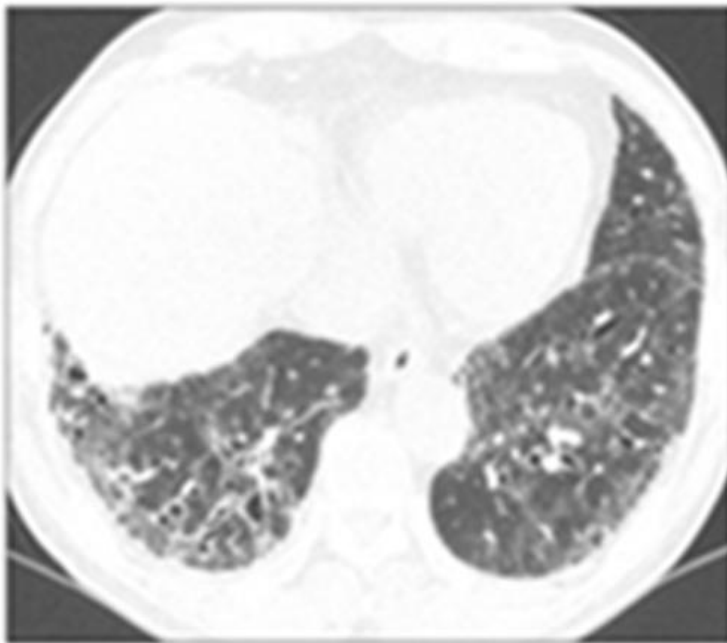
7. 57세 남자가 두 달 전부터 숨이 차다고 왔다. 마른기침이 있었고, 열은 없었다. 평소 다른 질환이나 호흡기 이외 증상은 없었고, 비흡연자였다. 혈압 120/80 mmHg, 맥박 70회/분, 호흡 22회/분, 체온 36.5℃ 였다. 양쪽 가슴에서 미세 거품소리가 청진되었다. 혈액 검사, 폐기능 검사 결과와 가슴 컴퓨터단층촬영 사진이다. 다음으로 시행할 검사는?

혈액검사

백혈구 9,000/mm³(중성구 30%, 림프구 68%, 호산구 2%),
혈색소 13.2 g/dL, 혈소판 350,000/mm³

폐기능검사

강제폐활량(FVC) 정상예측치의 70%,
1초간 강제날숨량(FEV1) 정상예측치의 88%,
1초간 강제날숨량/강제폐활량(FEV1/FVC) 84%



- 1) 심초음파
- 2) 가래 그람염색
- 3) 환기/관류 스캔
- 4) 가는바늘흡인검사
- 5) 비디오보조흉강경 폐생검

20190624 의학과2 호흡기학

8. 66세 남자가 3일 전부터 평소보다 숨이 더 차다며 응급실로 왔다. 1년 전부터 평지를 걸으면 숨이 차서 힘들었다고 한다. 2주 전부터 감기 기운이 있었고, 3일 전부터는 조금만 걸어도 숨이 더 찼다. 25갑년의 흡연자이다. 혈압 130/80mmHg, 맥박 118회/분, 호흡 32회/분, 체온 36.5℃이다. 식은땀을 흘리고 있으며 가슴 청진에서 심음은 정상이고 양쪽 부위에 거품소리가 들린다. 6개월 전 가슴 X선사진과 응급실에서 시행한 가슴 X선사진이다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 진단은?

혈액

혈색소 14.6g/dL, 백혈구 8,800/mm³ (중성구 55%)
혈소판 220,000/mm³ C-반응단백질 15mg/L (참고치, <10)
뇌나트륨이노펩티드 80ng/L (참고치, <100)
D-이량체 450ng/mL (참고치, 220~740)

동맥혈가스

(대기호흡) pH 7.42, PCO₂ 35mmHg PO₂ 42mmHg

6개월 전



응급실



- 1) 기관지폐렴
- 2) 급성심부전
- 3) 인플루엔자폐렴
- 4) 광범위폐포출혈
- 5) **특발폐섬유증의 급성악화**

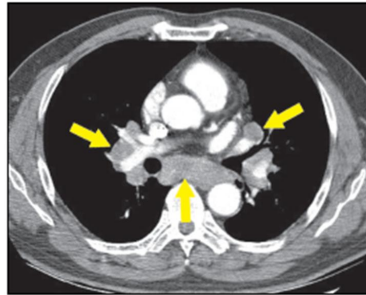
20190624 의학과2 호흡기학

9. 50세 남자가 3일전부터 발열, 마른기침, 호흡곤란 증상으로 왔다. 3주전 고향에 추수 일을 도와 드렸다고 한다. 흉부 X선 검사에서 양측 폐에 전체적인 음영이 증가되어 있었다. 입원하여 검사를 계획하던 중 증상과 흉부 X선에서 보였던 병변이 호전되었다. 치료는?

- 1) 항생제
- 2) 항진균제
- 3) 회피요법
- 4) 기관지확장제
- 5) 글루코코르티코이드

20190624 의학과2 호흡기학

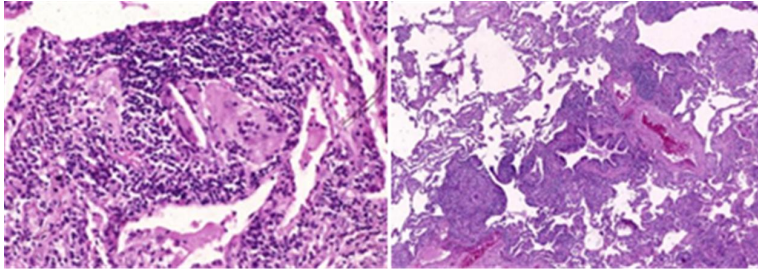
10. 53세 여자가 건강검진에서 발견된 가슴 X선 사진 이상으로 왔다. 비흡연자로 호흡기 증상은 없었다. 피부 병변이나 시력장애는 없었고 심잡음도 들리지 않았다. 가슴 X선 사진과 가슴 컴퓨터단층촬영 사진이다. 진단은?



- 1) 신경종(neuroma)
- 2) **사르코이드증(sarcoidosis)**
- 3) 기관지낭(bronchogenic cyst)
- 4) 폐색전증(pulmonary embolism)
- 5) 과민폐렴(hypersensitivity pneumonitis)

20190624 의학과2 호흡기학

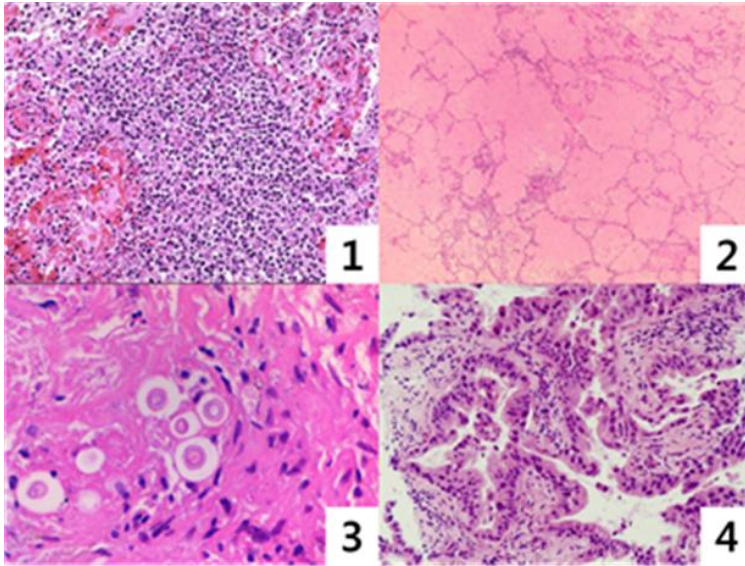
11. 농부폐 Farmer's lung 이라고도 불리는 이 질환에 대한 설명으로 틀린 것을 고르시오.



- 1) 유기항원에 급격한 노출로 발생하는 것으로 제형 과민반응과 관계가 있다.
- 2) 병리 소견으로는 벌집폐, 사이질폐렴, 비치즈육아종 등으로 나타난다.
- 3) 만성 경과를 거쳐 호흡곤란, 청색증까지 나타날 수 있다.
- 4) 항원 노출이 지속되면 만성사이질폐질환의 형태로 나타난다.
- 5) 기관지의 면역손상에 의한 기관지천식과는 달리 폐포의 과민 면역 손상으로 나타난다.

20190624 의학과2 호흡기학

12. Pulmonary alveolar proteinosis (PAP) 의 병리 소견을 고르시오.



- 1) 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4

20190624 의학과2 호흡기학

13. 분진으로 인한 진폐증에서 가장 먼저 침착하는 부위는?

- 1) trachea
- 2) bronchus
- 3) terminal bronchiole
- 4) **respiratory bronchiole**
- 5) acinar sac

20190624 의학과2 호흡기학

14. 석면에 장기간 노출된 사람들에서 발생 위험이 높아지는 종양에 대한 설명을 고르시오.

- 1) Epithelioid type 과 Sarcomatoid type 이 있으며 TTF-1 및 MDM2 염색으로 확진할 수 있다.
- 2) 세포 소견에서 Curschmann's spirals 가 관찰된다.

3) 석면에 장기간 노출된 사람의 7-10%에서 발생한다.

- 4) 폐가 양측성으로 심한 울혈을 보이는 것이 특징이다.
- 5) Mesothlioma 가 대표적인 양성 종양이다.

20190624 의학과2 호흡기학

15. 81세 남자가 우연히 단순 폐촬영상 좌상부 폐엽에 종괴가 발견되어 내원하였다. 과거력상 흡연력(하루 한 갑, 50년간)이 있었으며 기관지경 검사상 기관지 내에는 이상소견이 없었고 전산화단층촬영과 함께 유도 조직 검사에서 편평상피암으로 진단을 받았다. 흉부 전산화 단층 촬영 상 폐의 종괴는 2.5cm이었고 정상 폐조직에 둘러싸여 있었으며 림프절은 커져 있지 않았다. PET/CT에서는 종괴에 hypermetabolic lesion이 보였으나 림프절전이나 원격전이는 없었다. 폐기능 검사에서 severe restrictive ventilation defect 소견이었다. 이 환자에 대한 설명으로 맞는 것은?

- 1) 폐기능이 나빠 수술이 어려우면 SBRT(stereotactic body radiotherapy)로 완치가 가능하다.
- 2) 병기는 T1cN0M0이며 고령이지만 최적의 치료는 수술이다.
- 3) 폐암 중 림프절 전이 가능성이 가장 높은 병리형태이다.
- 4) 수술 후 종격동 림프절전이가 있으면 추가적인 방사선치료는 필요 없다.

20190624 의학과2 호흡기학

16. 다음중 소세포폐암의 치료에 대한 설명이다. 맞는 것은 ?

- 1) 소세포폐암은 방사선치료와 항암약물요법에 모두 높은 치료반응을 나타내므로 제한 병기에서는 방사선치료나 항암화학요법 중 단일치료법으로 치료한다.
- 2) 초기 소세포폐암은 수술이 우선적인 치료이다.
- 3) 소세포폐암에 의한 Superior vena cava syndrome은 방사선치료나 항암화학요법으로 증상완화를 얻을 수 있다.
- 4) 치료에 의해 흉곽내 폐암이 완전관해가 되면 예방적 전뇌방사선치료는 필요 없다.

20190624 의학과2 호흡기학

17. 흉강경수술의 어려울 것으로 판단되는 환자는?

- 1) 후종격동에서 발생한 종양 환자
- 2) 재발성 기흉으로 완전 폐허탈 환자

3) 흉막비후가 의심되는 폐결절 환자

- 4) 흉수를 동반한 흉막종양의증 환자
- 5) 흉수를 동반한 심낭삼출 환자의 심낭생검

20190624 의학과2 호흡기학

18. 우상엽절제술 시행 2달후 단순 흉부사진 소견으로 합당한 것은?

1) 기관이 동측으로 편향되어 있다

2) 좌측의 늑간 간격이 우측보다 좁다

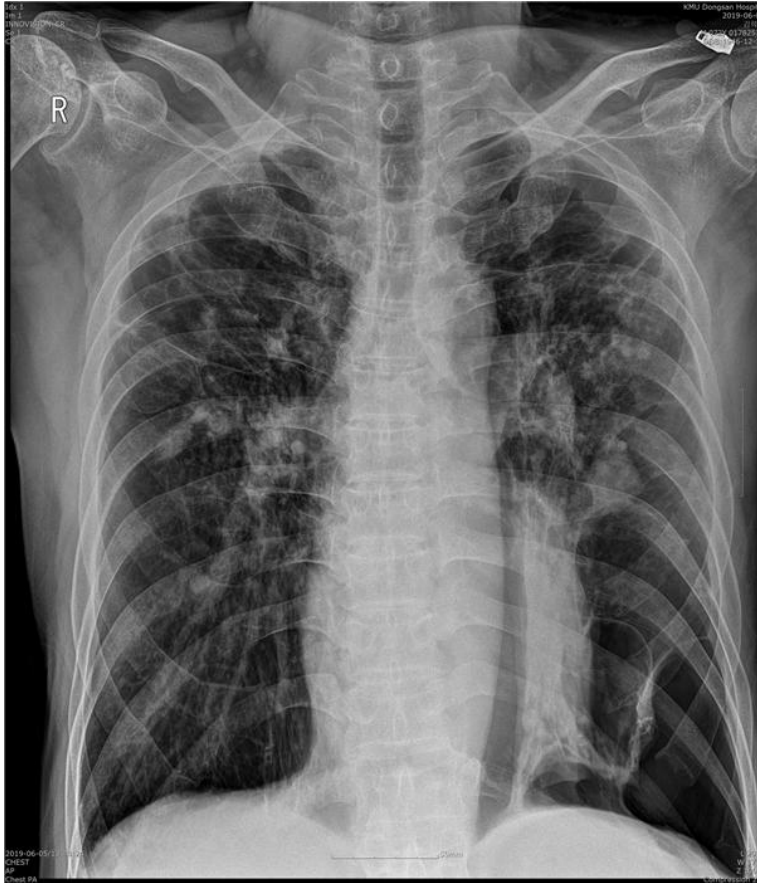
3) 좌우의 가로막 위치가 같다

4) 위장의 공기음영이 소실되었다.

5) 대동맥궁 음영이 소실되었다.

20190624 의학과2 호흡기학

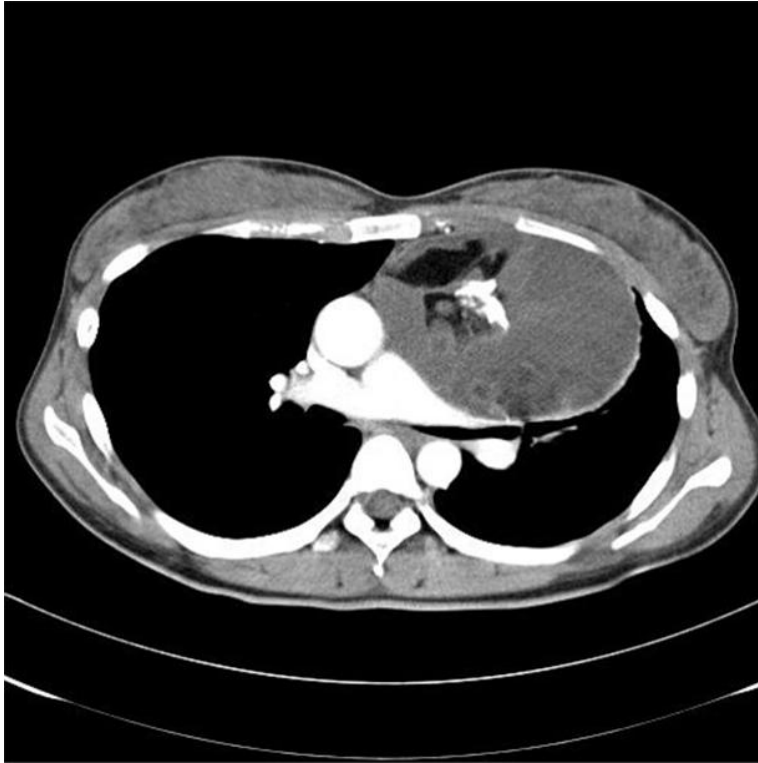
19. 만성폐쇄성 폐질환으로 치료받고 있는 환자가 급작스런 호흡곤란의 악화, 식은 땀, 빈맥을 주소로 내원하였다. 응급촬영한 흉부사진은 아래와 같았다. 가장 중요한 치료는?



- 1) 기관지확장제
- 2) 이뇨제
- 3) 기관삽관술
- 4) 산소공급
- 5) **흉관삽입술**

20190624 의학과2 호흡기학

20. 흉통을 주소로 내원한 환자의 흉부전산화 단층 촬영소견이다. 가장 의심되는 진단은?



- 1) 폐농양
- 2) 폐암
- 3) 흉선종
- 4) 기형종**
- 5) 폐쇄성 폐렴

20190624 의학과2 호흡기학

21. 소아 호흡기 발달에 관한 설명으로 바른 것은?

- 1) 임신 4-8주경에 발생이 완성된다.
- 2) 폐포 → 세기관지 → 기관지 → 기관 의 순서로 발달된다.
- 3) 임신 32주 지나면서 제 1형, 제 2형 세포가 출현하여 가스교환이 가능하다.
- 4) **출생 후 2세까지 폐포, 세기관지의 성숙이 가능하다.**
- 5) 출생 후 혈관보다 air space의 성장이 더 빨라서 효율적인 가스교환이 일어난다.

20190624 의학과2 호흡기학

22. 다음 질환중 기도 폐쇄의 특징을 바르게 표현한 것은?

- 1) 기도의 완전 폐쇄일 때 무기폐가 발생한다.
- 2) 천식으로 인해 흉곽내 폐외 기도 폐쇄가 발생한다.
- 3) 기도저항은 기도 반지름에 비례, 기도 길이에 반비례한다.
- 4) 흉곽 내 기도 폐쇄일 때 흉곽 외 폐쇄보다 폐쇄 정도가 심하다.
- 5) 기도가 부분 폐쇄되면 폐포의 공기 유입이 증가되어 폐가 과팽창된다.

20190624 의학과2 호흡기학

23. 소아 호흡부전에 대한 설명으로 맞는 것은?

- 1) 가슴답답함, 코 벌렁임 만으로는 호흡부전 양상으로 볼 수 없다.
- 2) 선천성 심질환에서는 호흡 부전이 발생할 수 없다.

3) 소아에서 기도를 확보하기 위해서 두부후굴 하악거상법을 시행한다.

- 4) 산소 치료는 산소포화도가 100% 되도록 하는 것이 좋다.
- 5) 60% 산소를 주어도 동맥혈 산소 농도가 60mmHg가 되지 않으면 100% 산소를 준다.

20190624 의학과2 호흡기학

24. 3세 남아가 잦은 기침으로 병원에 왔다. 3일전부터 37.6도의 열이 있었고, 코막힘이 심해 잠을 잘 자지 못하며, 진한 노란색의 끈적한 콧물을 보였다. 올해 3월부터 어린이집을 다니고 있으며, 현재까지 5번 정도의 감기로 병원을 다녔다고 하였다. 환아에 대한 설명으로 맞는 것은?
- 1) 누런 콧물은 세균감염을 시사하므로 항생제를 투여한다.
 - 2) 감기의 빈도가 잦으므로 면역 저하에 관련된 검사를 시행한다.
 - 3) 증상의 가장 흔한 원인은 respiratory syncytial virus 이다.
 - 4) 중이염이 잘 동반되므로 항생제를 조기에 시작해야 한다.
 - 5) 항히스타민제로 콧물, 코막힘을 호전시켜준다.

20190624 의학과2 호흡기학

25. 15개월 여아가 쉼 목소리로 킁킁거리는 기침을 하여 응급실로 왔다. 금일 낮부터 39도의 고열과 함께 목이 아프다고 하였고, 오후가 되면서 숨을 들쉴 때 가슴이 들썩거린다고 하였다. 청진에서 흡기시 협착음이 들렸고 흉부 함몰이 심하였다. 체온 38.5도, 호흡수 32회/분, 경피 산소포화도 90%였고, 많이 쳐져있었다. 가장 많은 원인은?

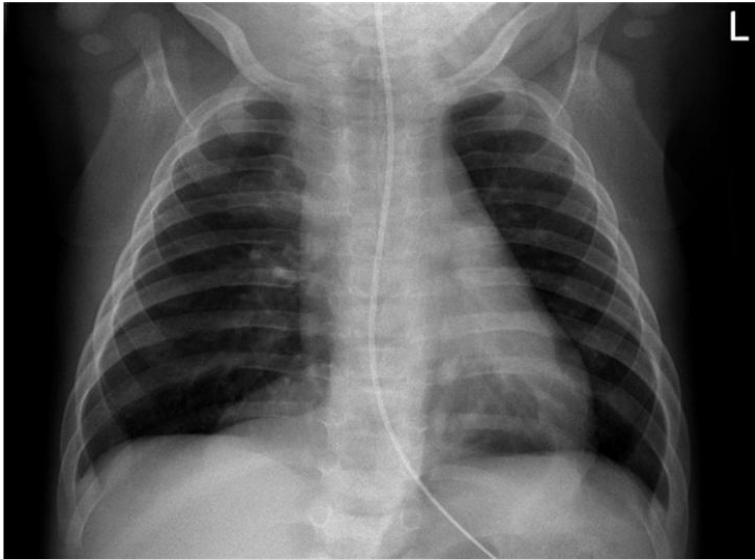
- 1) S. pneumoniae
- 2) Parainfluenza virus

3) H. influenza type B

- 4) Mycoplasma pneumoniae
- 5) Respiratory syncytial virus

20190624 의학과2 호흡기학

26. 3개월 남아가 발열과 호흡곤란으로 병원에 왔다. 출생 후 특별히 아픈 적 없이 잘 지냈는데, 3일전부터 기침 및 콧물을 보였고, 1일전부터 기침 심해지면서 숨쉴 때 쌉쌉거리는 소리가 들렸다. 심박수 135회/분, 호흡 65회/분, 체온 38.1℃, 경피 산소포화도 93%였다. 환아는 많이 보채면서, 호흡 시 늑간 함몰이 있었고, 가슴 청진에서 천명과 미세 수포음이 들렸다. 가슴 X-선 사진은 다음과 같았다. 환자의 처치로 바른 것은?



- 1) 보챔이 심하면 중환자실 입원하여 진정제를 투여한다.
- 2) 수포음이 들리므로, 광범위 항생제 주사 치료 시작한다.
- 3) 가족 내 전파가 잘 발생하므로 예방적 항생제가 필요하다.
- 4) 잘 못 먹으면 정맥 수액으로 수분을 보충하면서 지켜본다.
- 5) 주된 원인이 인플루엔자바이러스이므로 타미플루는 사용한다.

20190624 의학과2 호흡기학

27. 2개월 남아가 숨쉴 때 시끄러운 소리가 들리면서 숨쉬기 힘들어 보인다고 병원에 왔다. 출생 후 2주부터 숨을 들이쉴 때 시끄러운 천명음이 들렸으며, 환아를 엎어 누이면 증상이 완화 된다고 한다. 수유할 때 소리가 심해 지나 수유 양은 적절했고, 체중 증가도 잘되고 있었다. 향후 치료는?

1) 수술

2) 경과 관찰

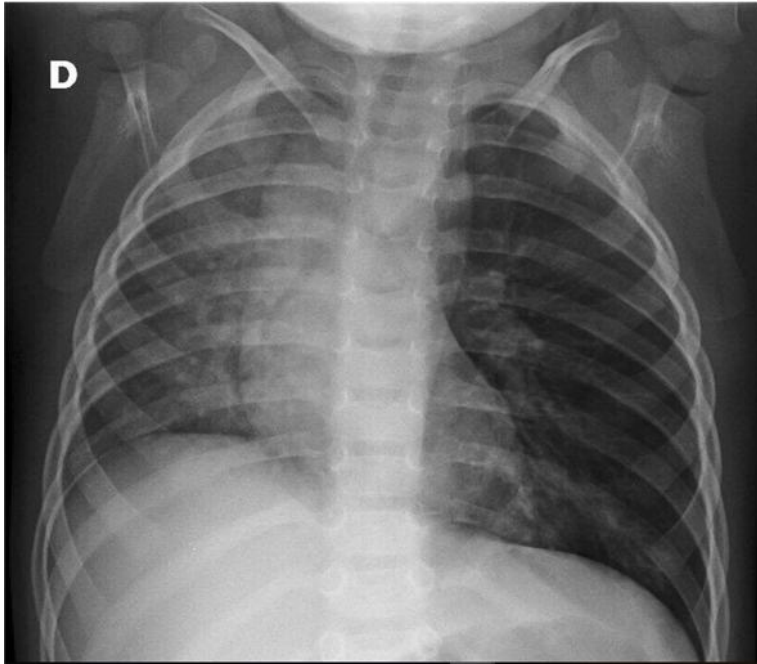
3) 항생제 복용

4) 기관지확장제 흡입치료

5) 기관지내시경을 통한 성형술

20190624 의학과2 호흡기학

28. 4세 남아가 갑작스러운 기침과 숨쉴 때 들리는 천명음으로 병원에 왔다. 기침이 있기 전 누나와 같이 간식을 먹던 중이었다고 한다. 심박수 115회/분, 호흡 35회/분, 체온 37.1℃, 경피 산소포화도 94%였다. 흉부 사진은 다음과 같았다. 처치는?



- 1) 경과 관찰
- 2) 위 내시경
- 3) 기관지 내시경
- 4) 폐쇄 흉관 삽관술
- 5) 기관지확장제 흡입치료

20190624 의학과2 호흡기학

29. 재태기간 37, 출생체중 2,800 g인 신생아가 수유중 기침과 호흡곤란을 보였다. 산모는 양수과다증이 있었고 입안에 침과 분비물이 많았다. 진단법은?

- 1) 식도조영술
- 2) 흉부심초음파
- 3) 위장관조영술
- 4) 위식도내시경

5) **입위관삽입 후 단순흉부촬영**

20190624 의학과2 호흡기학

30. 재태기간 36주, 출생체중 2,990 g인 신생아가 출생후부터 심한 호흡곤란과 함께 우측폐에 호흡음이 들리지 않았다. 흉부청음시 우측에서 장음이 들렸다. 기도삽관 후 단순흉부촬영을 시행하였다. 진단은?



- 1) 선천성기흉
- 2) 태변흡입증후군
- 3) **선천성횡격막탈장**
- 4) 신생아호흡곤란증후군
- 5) 식도폐쇄와 기관식도쇄갈

20190624 의학과2 호흡기학

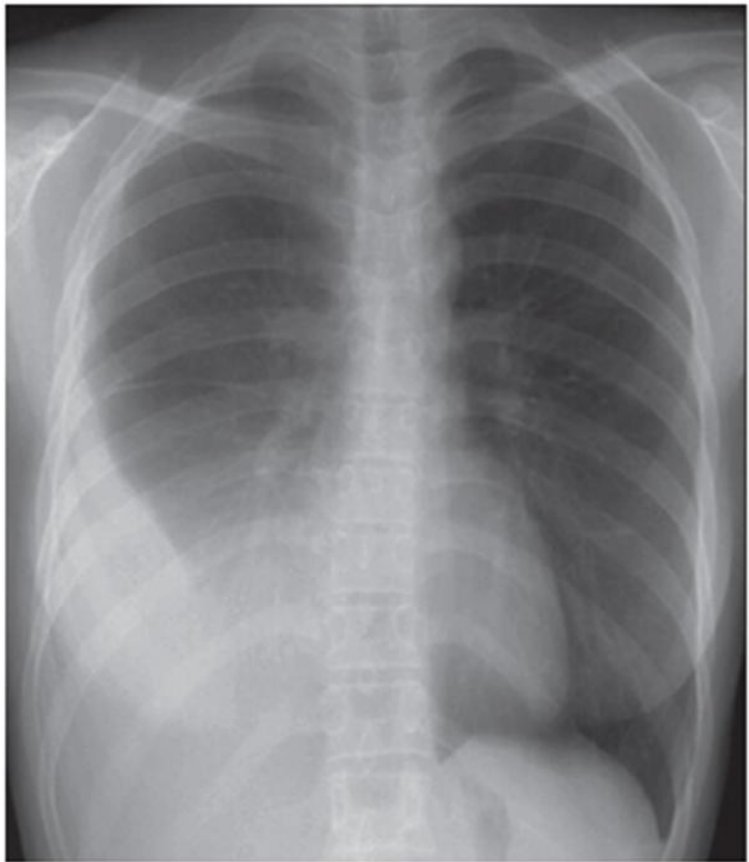
31. 30세 여자가 5일전부터 숨이 차고 가슴이 아파서 병원에 왔다. 최근 2개월 사이에 2kg 체중감소가 있었다고 하였다. 혈압 130/80mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 16회/분, 체온 38.2℃였다. 오른쪽 아래가슴 청진에서 호흡음이 잘 들리지 않았다. 가슴 X선사진이다. 검사 결과는 다음과 같았다. 진단은?

혈액

백혈구 12,000/mm³, 단백질 6.5g/dL
젖산탈수소효소 600 U/L (참고치, 115-220)
포도당 80 mg/dL

가슴막삼출액

백혈구 600/mm³ (중성구 20%, 림프구 80%)
단백질 6.5g/dL
아데노신탈아미노효소(ADA) 120 U/L
포도당 60 mg/dL



- 1) 울혈심부전
- 2) 결핵가슴막염
- 3) 악성가슴막삼출

4) 부폐렴가슴막삼출

5) 류마티스가슴막염

20190624 의학과2 호흡기학

32. 40세 남자가 건강검진에서 가슴 X선사진에 이상이 있다고 병원에 왔다. 20갑년의 흡연자였다. 기침, 가래, 체중감소는 없었다. 혈압 118/76mmHg, 맥박 68회/분, 호흡 16회/분, 체온 36.6℃였다. 가슴청진에서 호흡음은 정상이었다. 가슴 X선사진이다. 혈액검사 결과는 다음과 같았다. 검사는?

칼슘 12.1 mg/dL (참고치, 8.7 ~ 10.2), 알부민 4.3 g/dL



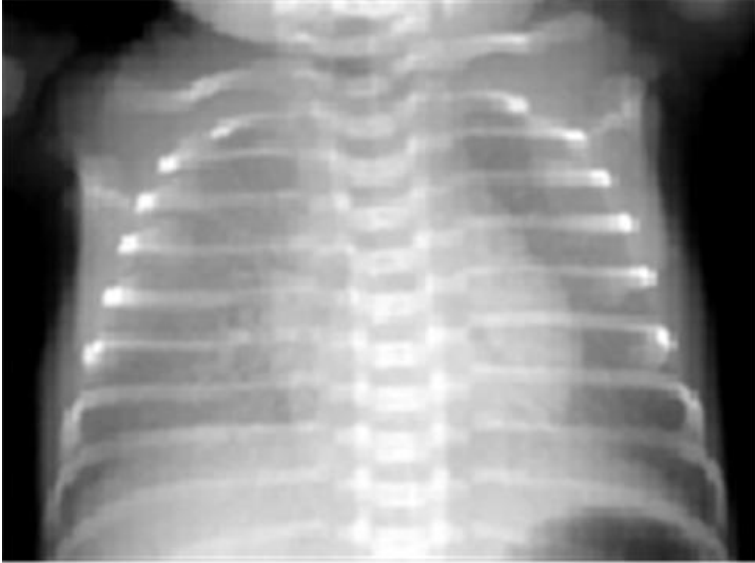
- 1) 뼈스캔
- 2) 갑상샘초음파
- 3) **가슴컴퓨터단층촬영**
- 4) 복부컴퓨터단층촬영
- 5) 피부경유가는바늘생검

33. 다음 질환에 대한 설명으로 옳은 기술은?



- 1) 좌측폐의 전방에 호발한다.
- 2) 병소측 폐의 대상성비대가 동반된다.
- 3) 복부 팽만이 관찰된다.
- 4) **종격동이 반대측으로 전위된다.**
- 5) 양수과다증이 동반된다.

34. 다음 X-선 소견과 관계있는 질환은?



- 1) IUP 41 weeks
- 2) Cesarian section
- 3) Congenital heart disease
- 4) Polyhydramnios
- 5) **Necrotizing enterocolitis**

20190624 의학과2 호흡기학

35. 폐이식술의 공여폐(donor lung)적응 기술에서 바른 사항은?

- 1) 적정연령이 55세 이상이다.
- 2) 기관지경검사는 생략해도 좋다.
- 3) 이전의 흉부수술과는 무관하다
- 4) ABO blood group의 match는 필요하지 않다.
- 5) **적정한 ABGA소견은 FiO₂ 1.0과 PEEP 5cmH₂O에서 PaO₂ 300 mmHg이상이다.**

20190624 의학과2 호흡기학

36. 흉부 영상학에서 소위 GGO(Ground Glass Opacity)음영과 폐암과의 관계를 올바르게 기술한 사항은?

- 1) 3cm 이상의 타원형 병변
- 2) 병변경계가 깨끗하다
- 3) 병변이 3개월이상 지속
- 4) 크기의 변화는 없는 것이 특징
- 5) 조직검사나 절제수술은 필요없다.

20190624 의학과2 호흡기학

37. Tracheal surgery(기관수술)에 관한 기술 중 맞는 사항은?

- 1) 기관절제 및 단단문합시 절제기관의 한계는 5cm 까지이다.
- 2) 기관은 흉부대동맥에서 직접 혈류공급을 받는다.
- 3) 기관단단문합시 양측 기관의 전후면보다 측면을 더 박리하는 것이 좋다.
- 4) 기관삽관(tracheostomy)후 stomal stenosis는 stoma의 전측부 협착이 잘 온다.
- 5) 기관무명동맥의 누공(tracheoinnominate artery fistula)의 치료는 누공 부위를 포함한 혈관을 절제한후 인조혈관을 연결하는 것이 효과적 수술 이다.

20190624 의학과2 호흡기학

38. 폐암 병기 Ib에서 술후 보조항암치료(adjuvant chemotherapy)가 필요한 경우는?

- 1) 폐엽절제술후 모두 시행
- 2) 종양의 크기가 4cm 미만일 경우
- 3) 분화도가 좋은 경우

4) **흉막이 침범한 경우**

- 5) 혈관 침범은 없는 경우

20190624 의학과2 호흡기학

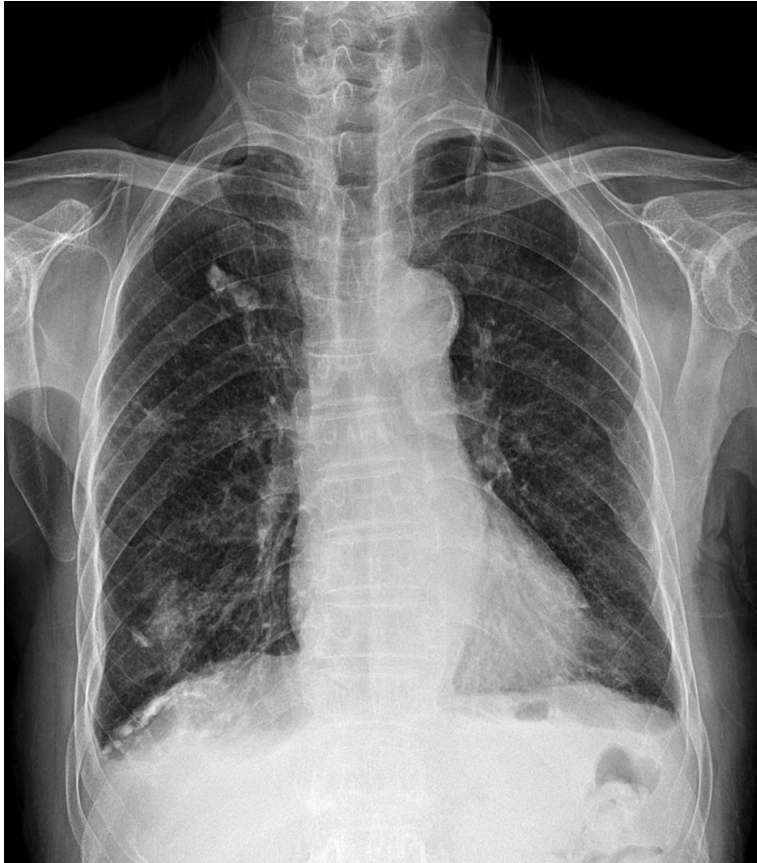
39. 52세 남자가 건강검진 가슴X선 사진 이상으로 내원하였다. 15년간 유리 공장에서 근무하고 있다. 3년 전에는 폐결핵을 진단받고 치료한 병력이 있으며 흡연력은 20갑년이다. 기침, 가래, 발열, 가슴통증은 없었다. 혈압은 128/72mmHg, 맥박 64회/분, 호흡 18회/분, 체온은 36.2였다. 목 주위에 림프절은 만져지지 않았고, 호흡음은 정상이었다. 다음은 가슴X선 사진과 가슴 컴퓨터단층촬영 사진이다. 진단은?

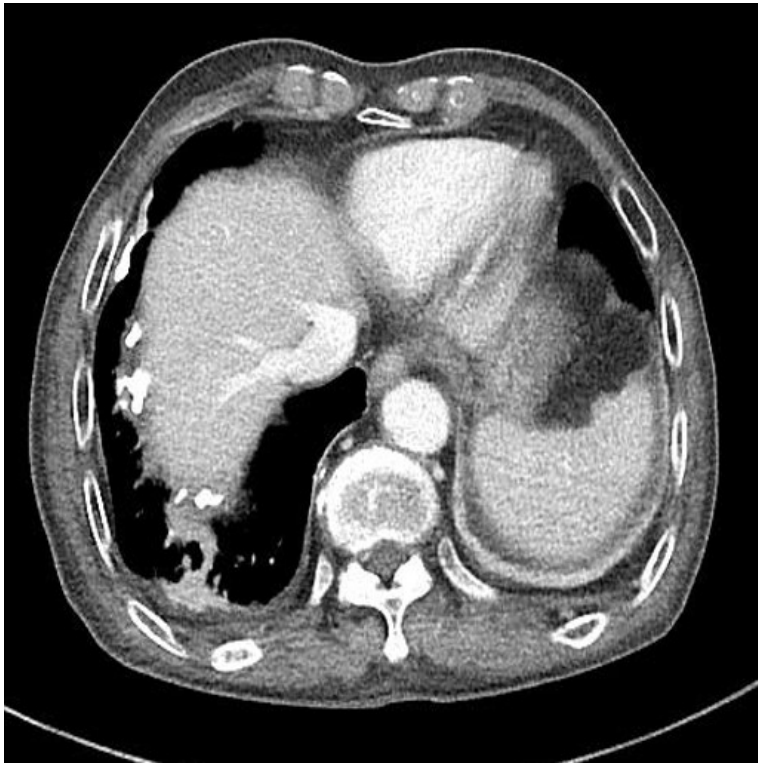


- 1) 석면증(asbestosis)
- 2) **규소폐증(pulmonary silicosis)**
- 3) 간질성폐질환(interstitial lung disease)
- 4) 만성폐쇄성폐질환(chronic obstructive pulmonary disease)
- 5) 폐결핵의 과거 흉터(old scar of pulmonary tuberculosis)

20190624 의학과2 호흡기학

40. 65세 남자가 2년 전부터 걸으면 숨이 차다고 내원하였다. 수년 전부터 기침, 가래가 있었고 일하거나 빨리 걸으면 숨이 찼다. 비흡연자이고 25년간 건물철거작업을 했다. 혈압은 135/82mmHg, 맥박 75회/분, 호흡 16회/분, 체온은 36.3였다. 가슴청진에서 호흡음은 정상이었다. 다음은 가슴 X선 사진과 가슴 컴퓨터단층촬영 사진이다. 진단은?

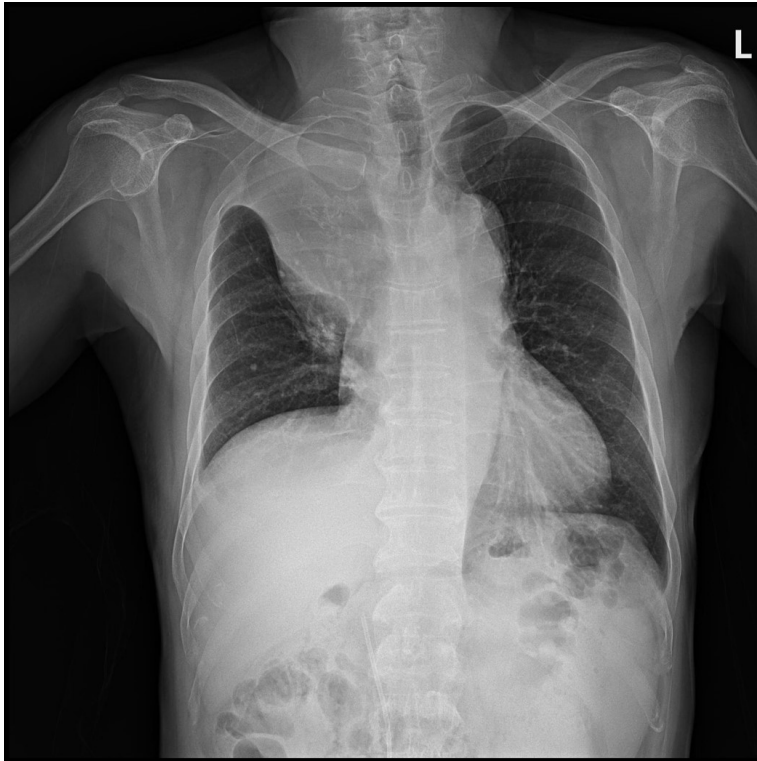




- 1) 석면증(asbestosis)
- 2) 규소폐증(pulmonary silicosis)
- 3) 폐먼지증(Pneumoconiosis)
- 4) 만성기관지염(chronic bronchitis)
- 5) 간질성폐질환(interstitial lung disease)

20190624 의학과2 호흡기학

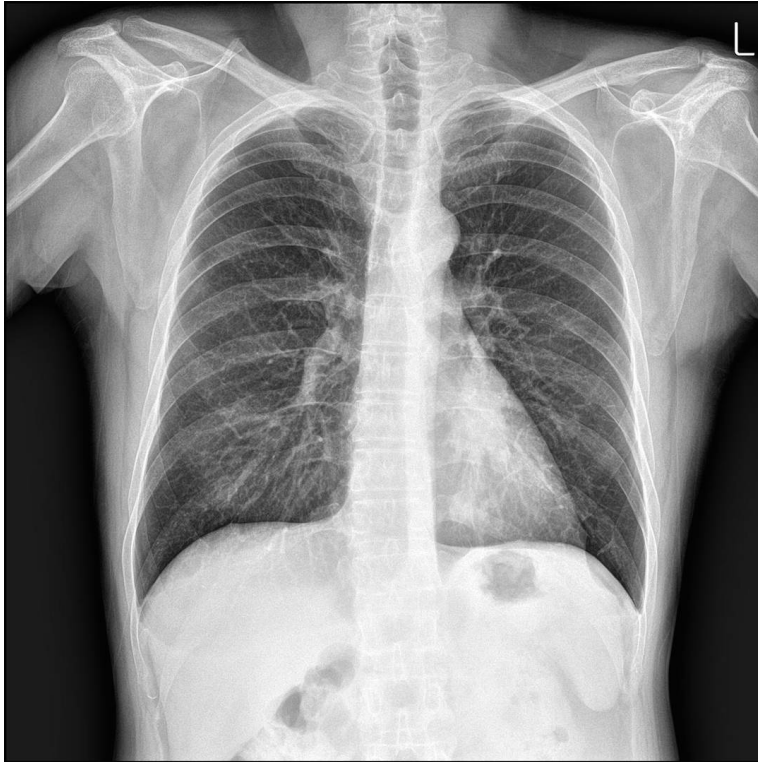
41. 68세 남자 환자가 최근 2개월 동안 기침이 지속되어 왔다. 3주 전부터는 목소리가 쉰 소리로 변하였다. 최근 3개월 동안 체중이 5kg 줄어들었다. 50갑년의 흡연력이 있었다. 혈압은 120/70 mmHg, 맥박수 84회/분, 호흡수 16회/분, 체온은 36.5℃이었다. 가슴 진찰에서 오른쪽 위 가슴부위에서 싹싹거림이 들렸고 다른 부위에서 호흡음은 정상이었다. 다음은 가슴 X선 사진이다. 검사는?



- 1) 흉강경검사
- 2) 기관지폐포세척술
- 3) 기관지내시경검사**
- 4) 피부경우가느바늘생검
- 5) 가래 항산막대균퍼바른표본과 배양검사

20190624 의학과2 호흡기학

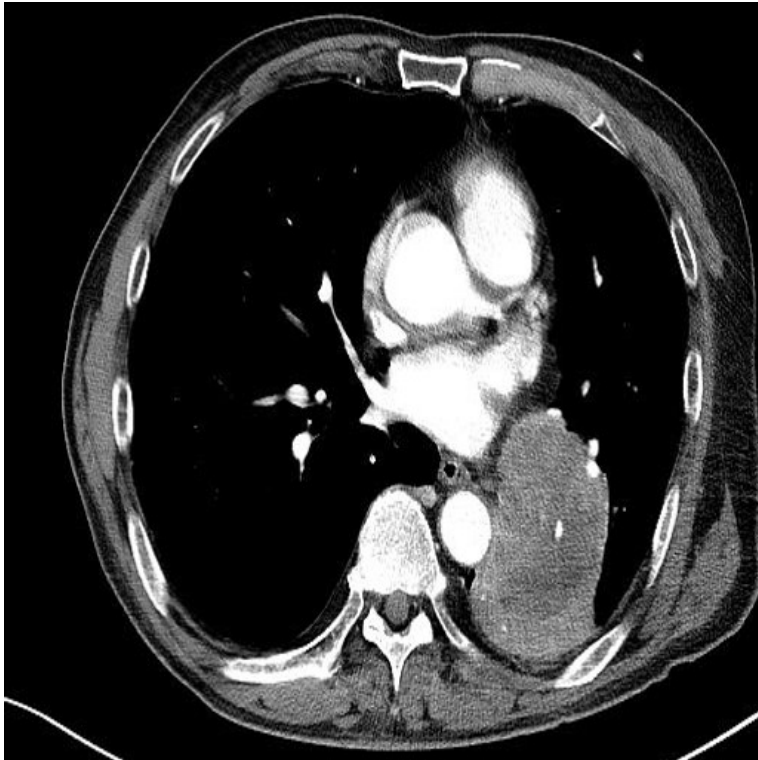
42. 62세 남자가 2달간 지속되는 기침으로 내원하였다. 3달간 5kg의 체중감소가 있고 평소에 있던 가래의 양도 늘어났다고 한다. 매일 1.5갑씩 40년간 담배를 피웠다고 한다. 혈압은 130/82 mmHg, 맥박 76회/분, 호흡 16회/분 체온은 36.5였다. 가슴 진찰에서 좌측 등쪽 가슴 아래부위에서 천명음이 들렸다. 다음은 가슴X선 사진이다. 진단은?

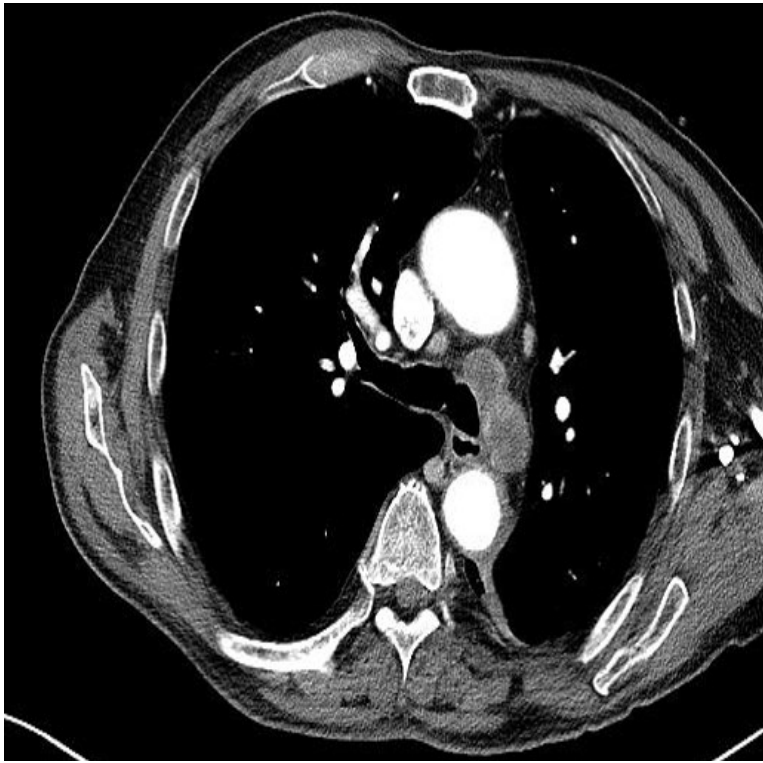


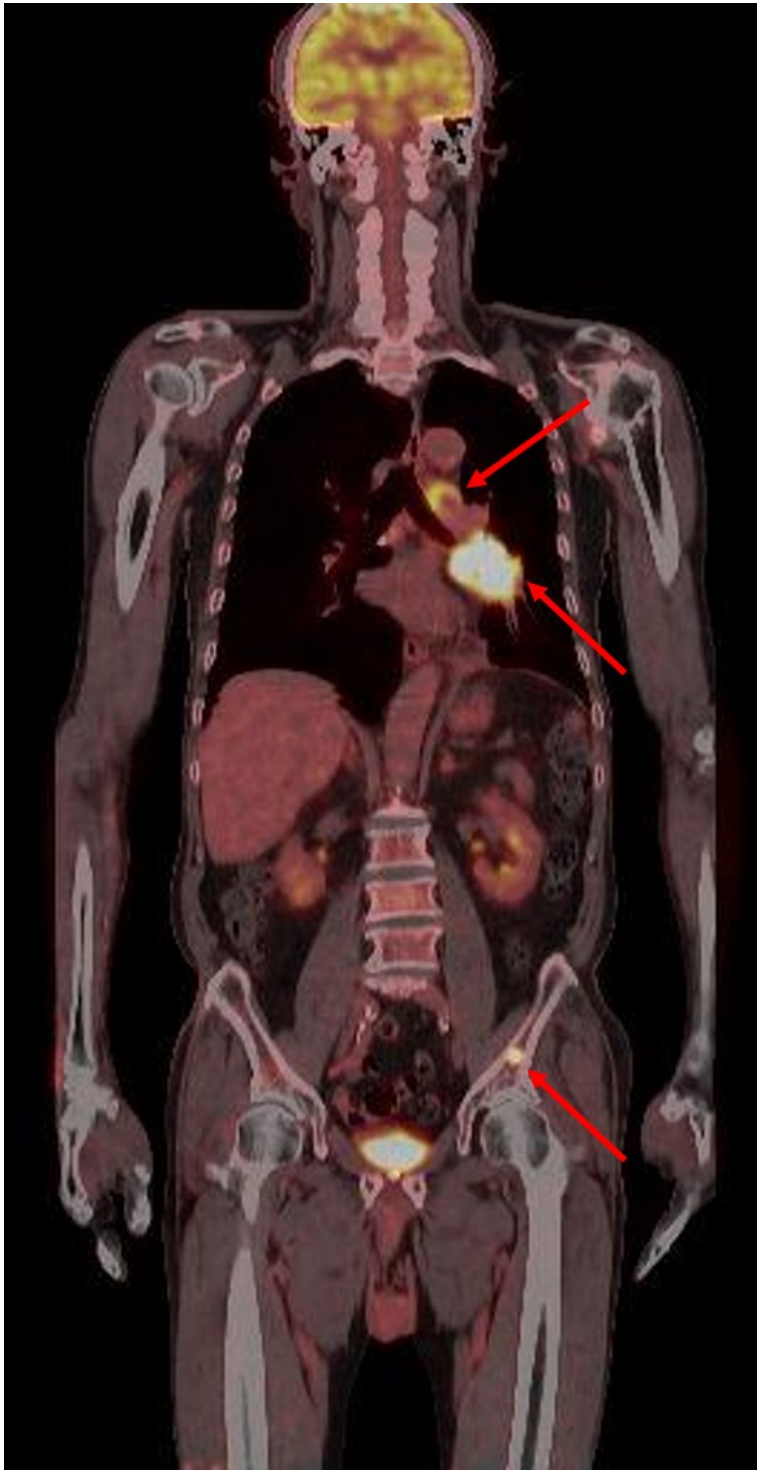
- 1) 폐렴(pneumonia)
- 2) 폐암(lung cancer)
- 3) 폐결핵(pulmonary tuberculosis)
- 4) 기관지 천식(bronchial asthma)
- 5) 기관지확장증(bronchiectasis)

20190624 의학과2 호흡기학

43. 75세 남자가 혈담으로 왔다. 55갑년의 흡연자였다. 기관지내시경검사에서 좌하엽을 막고 있는 종괴가 관찰되었고 편평상피세포폐암으로 진단되었다. 가슴 컴퓨터단층촬영에서 좌하엽 종괴의 크기는 9cm이고 왼쪽 아래 기관옆림프절(Left lower paratracheal lymph node) 2개의 크기가 2.5cm으로 커진 것 외에는 정상이었다. 머리 자기공명영상검사는 정상이었고 양전자방출단층촬영에서 좌측 장골에 하나의 뼈 전이가 확인되었다. 다음은 가슴 컴퓨터단층촬영 사진과 양전자방출단층촬영 사진이다. 병기는?







- 1) T3N2M1a Stage IVA
- 2) T3N3M1a Stage IVA
- 3) T4N2M1b Stage IVA**
- 4) T4N2M1b Stage IVB
- 5) T4N2M1c Stage IVB

20190624 의학과2 호흡기학

44. 다음은 상기 75세의 남자 환자의 편평상피세포폐암 병리조직에서 시행한 유전자검사 및 면역조직화학 검사결과이다. ECOG 수행척도 (Performance Scale) 3으로 전신상태가 좋지 않아 1st line치료로 면역치료 단독으로 시행하기로 결정했다. 치료는?

EGFR 유전자돌연변이검사 : Wild

ALK 유전자검사 FISH : Negative

PD-L1(22C3) : Positive 100%

PD-L1(SP263) : Positive 100%

PD-L1(SP142) : TC(Tumor cell) - 100%, IC(Immune cell) - 30%

1) Atezolizumab

2) Bevacizumab

3) Durvalumab

4) Nivolumab

5) **Pembrolizumab**

20190624 의학과2 호흡기학

45. 63세 남자가 3일 전부터 왼쪽 가슴이 아파 병원에 왔다. 2주일 전부터 기침, 가래와 함께 발열, 오한이 있었다. 3일 전부터는 숨을 들이쉴 때 왼쪽 가슴에 뜨끔하는 통증이 생겼다. 혈압 128/86 mmHg, 맥박 101회/분, 호흡 22회/분, 체온 38.3℃였다. 가슴 청진에서 왼쪽 호흡음이 감소되었다. 혈액과 가슴막삼출액 검사 결과는 다음과 같았다. 세프트리악손(ceftriaxone)과 클린다마이신(clindamycin)으로 치료를 시작하였다. 추가 치료는?

혈액

혈색소 13.2 g/dL, 백혈구 11,300/mm³ 혈소판 350,000/mm³,
단백질 6.6 g/dL, 포도당 102 mg/dL 젖산탈수소효소 430 U/L

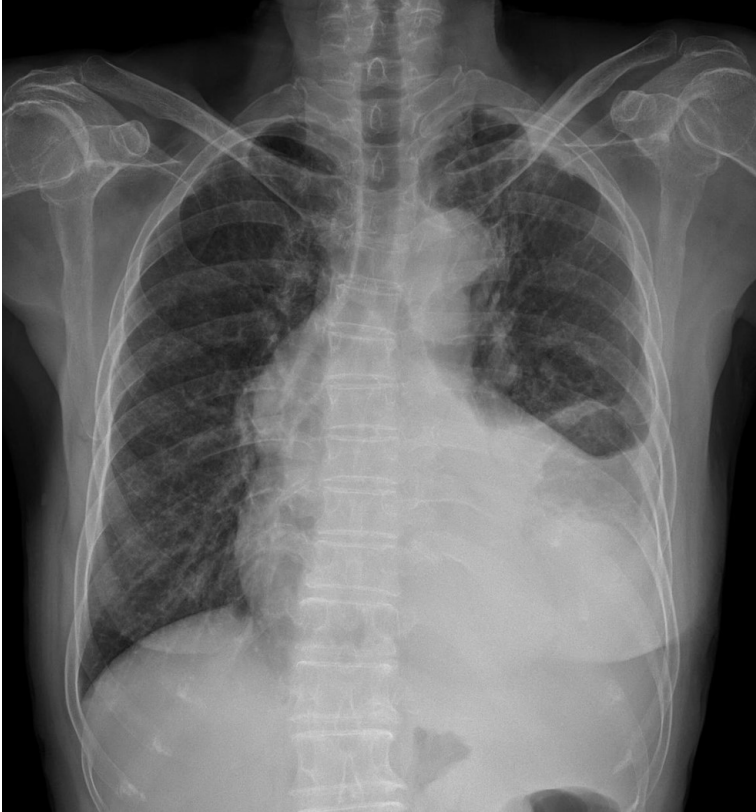
가슴막삼출액

pH 6.7, 백혈구 12,100/mm³ (중성구 81%, 림프구 19%)
단백질 4.1 g/dL, 포도당 25 mg/dL 젖산탈수소효소 1,100 U/L
아데노신탈아미노효소(ADA) 96 IU/L 암배아항원 1.4 ng/mL

- 1) 항결핵제
- 2) **가슴관삽입**
- 3) 가슴막유착술
- 4) 겔질제거(decortication)
- 5) 반코마이신(vancomycin)

20190624 의학과2 호흡기학

46. 79세 여자가 2주간 숨을 쉴 때 아픈 흉통과 호흡곤란을 주소로 외래로 내원하였다. 혈압은 130/80 mmHg, 맥박수 80회/분, 호흡수 12회/분, 체온은 36.5℃이었다. 흉부X선 소견은 다음과 같다. 진단을 위해 가장 먼저 해야 할 검사는?



- 1) 심장초음파
- 2) 기관지내시경
- 3) 가슴 컴퓨터단층촬영
- 4) 가래 퍼바른표본검사
- 5) 왼쪽으로 누워서 흉부방사선 촬영